EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 78711
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-09 09:42:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MYRIAM DELIA CONTRERAS LABRIN			RUN	: 9.639.160-9
F.Nac	: 03-02-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-04	Fecha Egreso	: 2024-02-09 09:42:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- ACV isquémico parietotemporal izquierdo. TH IH 1. Obs embolico.
- IC Fevi 44% Derrame pleural bilateral en mejoría
- Antecedentes: - Hipertensión arterial - Diabetes mellitus tipo 2 IR - Dislipidemia - Asma bronquial?

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PTE DE 63 AÑOS AUTOVALENTE CON ANTEC DESCRITOS TRAÍDA POR FAMILIARES POR ALTERACIÓN DEL LENGUAJE. ES EVALUADA EN URGENCIAS CON HDN ESTABLE, SE REALIZA TAC DE CEREBRO DONDE SE EVIDENCIA ISQUEMIA AGUDA PARIETOTEMPORAL IZQ, Y SE HOSPITALIZA PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO POR NEUROLOGIA
INGRESA A SALA ESTABLE, HDN AUTOSOSTENIDA, RS EN MONITOR, SIN INTERCUREENCIAS INFECCIOSAS
EX. NEUROLÓGICO:
VIGIL, ORIENTACION NO VALORABLE POR TRAST DEL LENGUAJE AFASIA DE WERNICKE, SIN DISARTRIA
PUPILAS ISOCORICAS 3MM, RFM +/+, MOC CONSERVADOS, CV IMPRESIONA HEMIANOPSIA DERECHA CON REFLEJO DE AMENAZA, NO HAY ASIMETRIAS FACIALES, NI ALTERACION DE SENSIBILIDAD EN CARA, LENGUA PROTRUYE CENTRAL
MOTOR ALCANZA M5 EN LAS 4 EXTREMIDADES, HIPOREFLEXIA EN MII, CUTANEO PLANTAR INDIFERENTE DERECHO FLEXOR IZQUIERDO
HEMIHIPOESTESIA ALGESICA DERECHA
FUNCIONES CEREBELOSAS POCO EVALUABLES POR FALTA DE COLABORACIÓN DE LA PACIENTE
SIGNOS MENINGEOS NEGATIVOS.
DURANTE EIH SE PESQUISA DERRAME PLEURAL BILATERAL QUE MEJORA CON TERAPIA DEPLETIVA POSTERIORMENTE BUENA EVOLUCIÓN CLÍNICA DURANTE 6 DÍAS SIN DETERIORO NEUROLÓGICO CON MEJORÍA DE AFASIA SENSITIVA, SE DECIDE ALTA MEDICA CON HODOM PARA CONTINUAR REHABILITACIÓN FONOAUDIOLOGICA Y KINESICA EN DOMICILIO

PLAN DE MANEJO:

CONTROL EN POLI DE NEUROLOGÍA EN 10 DÍAS
TOMAR HOLTER AMBULATORIO

INDICACIONES AL ALTA

1. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL

2. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
3. FAMOTIDINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD realizar 2 puff cada 6hrs

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 09/02/24 Glic 110 creat 0.70 PCR 30.0 ELP 141/3.3/ 109 inr 1.22 tp 74 ttpa 26
- Ecocardiograma: Grosores parietales aumentados del ventriculo izquierdo con alteración de la relajación y función sistolica Fevi 44%. Función Sistolica biventricular conservada. Moderada dilatación de auricula izquierda. VD normocontractil
- 08/02/24 TAC de cerebro control con lesión hipodensa isquemica parietotemporal izquierda con escaso petequiado hemorragico. IH 1
- Rx de tórax con derrame pleural bilateral en mejoría
- 06/02/24 Glic 109, Creat 0.7, MDRD 84.5. Uremia 27, ELP 138/3.8/109, Hb 12.7, Hto 37.4, leuco 11700, Plaq 279.000, VHS 39, PCR 34.4. INR 1.12. TTPa 22. RPR no reactivo.
- 05/02/24 Creat 0.6, MDRD 100, ELP 140/4.0/112, LDH 467. INR 1.22. TTPa 28. proBNP 9000. TSH 1.173, T4L 0.91
- 04/02/24 AngioTC de cerebro y cuello: estenosis de segmento M2 posteroinferior izquierda. Sin otras estenosis significativas intra ni extracraneanas.
- 04/02/24 Glic 172, Creat 0.7, MDRD 84.5, Uremia 26, ELP 137/3.5/109, Hb 11.4, Hto 33.0, Leuco 8100 (67% segm), Plaq 261.000, VHS 33, PCR 26.5. Procalc 0.05. INR 1.28, TTPa 25. ColT 121, HDL 23, LDL 81, TGL 85. TSH 1.023, T4L 1.22, VitB12 165, VitD 13.3, HbA1c 9.6. RPR no reactivo. OC no inflamatorio, UC negativo.
- 03/02/24 TC de encéfalo sin contraste: hipodensidad isquémica temporooccipital izquierda de aspecto subagudo, sin signo de transformación hemorrágicas y sin otras lesiones de aspecto antiguo

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO